

Drugi ciężar *psychozy*

Stygma jest często bardziej dotkliwa niż same objawy. Autostygma — internalizacja uprzedzeń — predykuje izolację, depresję i unikanie leczenia. Można z tym pracować.

CZAS: 10–15 min Po diagnozie · regularnie podczas leczenia

ŹRÓDŁO: Corrigan & Watson (2002); Yanos i in. (2012, NECT); Thornicroft i in. (2009, INDIGO)

JAK UŻYWAĆ

Poznaj **trzy typy stygmy** (sekcja 1), zrozum **mechanizm autostygmy** i jak ją rozpoznać (sekcja 2). W sekcji 3 — co działa przeciwko autostygmi. W sekcji 4 — wypełnij własną mapę przekonań.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Corrigan i in. (2004): stygma to *drugi ciężar* choroby psychicznej — często **bardziej upośledzający** niż same objawy. Thornicroft i in. (2009, badanie INDIGO w 27 krajach): **70% osób z psychozą** doświadcza dyskryminacji w pracy, relacjach intymnych, dostępie do opieki zdrowotnej. Autostygma (internalizacja uprzedzeń: „*jestem uszkodzony*”, „*nie zasługuję*”) jest **predyktorem** izolacji, depresji, niskiej adherencji i zwiększonego ryzyka suicydalności. Yanos i in. (2012) opracowali protokół *Narrative Enhancement and Cognitive Therapy* (NECT) — skuteczną interwencję psychologiczną przeciwko autostygmi. Stygma **nie jest Twoją winą** — jest skutkiem braku wiedzy społeczeństwa. Ale jej skutki są realne i można z nimi pracować.

01 = Trzy typy stygmy

STYGMA PUBLICZNA

Uprzedzenia społeczeństwa: „niebezpieczni”, „nieprzewidywalni”. Stereotypy w mediach. Dyskryminacja w pracy, relacjach. Ofiarą jest pacjent, źródłem — otoczenie.

AUTOSTYGMA

Internalizacja uprzedzeń: „*jestem uszkodzony*”, „*nigdy nie będę normalny*”. Sam pacjent uwierzył w stereotypy o sobie. Najbardziej toksyczna forma.

STYGMA STRUKTURALNA

Prawo, polityka, system. Trudniejszy dostęp do ubezpieczeń, kredytów, opieki somatycznej. *Diagnostic overshadowing* w szpitalach.

02 © Mechanizm autostygmy — „*why try effect*”

Corrigan i in. (2009): autostygma działa przez mechanizm „*why try effect*” — „*po co się starać, skoro i tak jestem uszkodzony*”. To samonapędzający się cykl, który **można przerwać**, ale wymaga świadomej pracy.

1. Pacjent słyszy/widzi negatywne stereotypy („*schizofrenicy nie pracują*”) → **2.** Zgadza się z nimi („*to chyba prawda*”) → **3.** Stosuje do siebie („*ja też nigdy nie będę pracować*”) → **4.** Wycofuje się, nie próbuje (*why try*) → **5.** Brak doświadczeń pozytywnych potwierdza stereotyp (samo-spełniająca się przepowiednia).

Punkt przerywania: krok 2 lub 3 — *kwestionowanie przekonań*. „*Czy faktycznie wszyscy się ze mną zgadzają? Skąd to wiem? Czy znam osoby z psychozą, które pracują?*” Praca poznawcza z autostygma jest dokładnie tym samym, co CBT z innymi zniekształceniami.

03 Co realnie działa przeciwko autostygmię

EDUKACJA OPARTA NA FAKTACH

Mit: „osoby z psychozą są niebezpieczne”. Fakt (Teplin 2005): są **10x częściej ofiarami** przemocy niż sprawcami.

KONTAKT Z PEER SUPPORT

Corrigan (2012): bezpośredni kontakt z osobami z doświadczeniem psychozy **najskuteczniej** redukuje uprzedzenia — własne i innych.

RECOVERY NARRATIVES

Historie osób żyjących pełnią z psychozą: Elyn Saks („Niewytłumaczone”), Patricia Deegan, Eleanor Longden. Konkretnie twarze zmieniają przekonania.

ZMIANA JĘZYKA TOŻSAMOŚCI

„Jestem schizofrenikiem” → „mam doświadczenia psychotyczne”. Psychoza to część tożsamości, nie cała tożsamość.

DECYZJA O UJAWNIENIU — TWÓJ WYBÓR

Nie musisz nikomu mówić o diagnozie. To *Twoja* decyzja, komu i kiedy. Pracodawca, znajomi, partner — różne osoby, różne ryzyko, różne korzyści. Z czasem niektórzy decydują się ujawniać świadomie — bywa to **wyzwalające**. Inni — nigdy. Obie ścieżki są w porządku.

04 Moje przekonania o sobie

Pierwszy krok pracy z autostygumą — rozpoznanie. Zapisz jedno przekonanie, które masz o sobie w związku z diagnozą, i sprawdź jego źródło. Często okazuje się, że nie pochodzi z *faktów*, lecz z *otoczenia*.

JEDNO TRUDNE PRZEKONANIE O SOBIE

— „nie zasługuję”, „nigdy nie będę...”, „jestem uszkodzony/a”

SKĄD ONO POCHODZI

— mediów, rodziny, kogoś konkretnego, czy z faktów

Klucz: stygma **nie jest Twoją winą** — jest winą społeczeństwa, które słabo rozumie psychozę. Nie musisz się *wstydzić* — możesz potrzebować *chronić* się przed tymi, którzy nie rozumieją. To dwie różne rzeczy. Yanos i in. (2012, RCT NECT): 20-sesyjna grupa łącząca psychoedukację, narracyjną pracę z historią życia i restrukturyzację poznawczą **znaczaco redukuje autostygmy** i poprawia samoocenę. Praca z autostygumą to *nie luksus* — to konkretne narzędzie zwiększające szanse na zdrowienie. Osoby z niższą autostygumą lepiej adherują do leczenia, mają więcej relacji, częściej wracają do pracy. Zaczynij od *jednego* przekonania — to wystarczy.